

CONSENTIMIENTO INFORMADO

EXODONCIA DE TERCEROS MOLARES (CORDALES)

Formato Clínico Profesional · Uso en Consultorio Odontológico

¿Para qué sirve este documento?

Este formato de consentimiento informado ha sido diseñado para ser utilizado en consultorios y clínicas odontológicas durante el proceso de exodoncia de terceros molares. Documenta la autorización libre y voluntaria del paciente, garantizando el cumplimiento de los estándares clínicos, éticos y legales vigentes.

Odontólogos Generales

Cirujanos Orales

Estudiantes de Odontología

Clínicas y Consultorios

Documento editable e imprimible · Formato A4 · Uso clínico profesional

DATOS GENERALES

Historia Clínica N.º:

Fecha:

DATOS DEL PACIENTE

Nombre completo:

Documento de identidad:

Edad:

Teléfono:

ODONTÓLOGO TRATANTE

Nombre:

Registro profesional:

TERCER MOLAR A EXTRAER

■ 18

■ 28

■ 38

■ 48

Posición clínica y radiográfica:

Diagnóstico clínico:

Diagnóstico radiográfico:

Motivo de la extracción:

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO

Yo, _____, identificado(a) con documento N.º _____, declaro que he recibido información **clara, suficiente y comprensible** acerca del procedimiento de **exodoncia de tercer molar o cordal**.

Comprendo que el procedimiento consiste en la extracción de uno o varios terceros molares debido a condiciones tales como **erupción incompleta, inclusión, impactación, pericoronitis, caries, enfermedad periodontal, reabsorciones dentarias, indicaciones ortodónticas, protésicas, quirúrgicas o preventivas** debidamente justificadas.

Comprendo que la complejidad de la extracción puede variar dependiendo de la **posición del diente, profundidad, forma radicular, densidad ósea** y proximidad a estructuras anatómicas importantes.

PROTOCOLO CLÍNICO DEL PROCEDIMIENTO

Se me ha explicado que el tratamiento podrá incluir una o varias de las siguientes fases:

- | | |
|--|--|
| ■ Evaluación clínica. | ■ Odontosección (sección del diente). |
| ■ Evaluación radiográfica. | ■ Luxación y extracción del tercer molar. |
| ■ Interpretación de radiografía panorámica y/o tomografía. | ■ Legrado y limpieza del alvéolo. |
| ■ Revisión de antecedentes médicos. | ■ Irrigación quirúrgica. |
| ■ Toma de signos vitales cuando esté indicada. | ■ Regularización ósea cuando sea necesaria. |
| ■ Aplicación de anestesia local. | ■ Colocación de material hemostático cuando esté indicado. |
| ■ Incisión quirúrgica cuando sea necesaria. | ■ Sutura. |
| ■ Despegamiento de colgajo mucoperióstico. | ■ Control postoperatorio. |
| ■ Osteotomía (eliminación controlada de hueso). | ■ Retiro de suturas cuando corresponda. |

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO

Comprendo que los beneficios esperados incluyen:

- | | |
|---|--|
| • Eliminación de dolor e infección. | • Prevención de enfermedad periodontal localizada. |
| • Prevención de episodios recurrentes de pericoronitis. | • Prevención de reabsorciones radiculares. |
| • Prevención de daño a dientes vecinos. | • Facilitar tratamientos ortodónticos o rehabilitadores. |
| • Prevención de caries asociadas. | • Mejorar la salud oral general. |

RIESGOS Y COMPLICACIONES

Comprendo que, aun siguiendo protocolos clínicos actualizados, pueden presentarse complicaciones:

RIESGOS GENERALES

- Dolor postoperatorio.
- Inflamación facial.
- Sangrado.
- Hematoma.
- Limitación de apertura bucal (trismus).
- Dificultad temporal para masticar.
- Dificultad temporal para hablar.
- Infección postoperatoria.
- Fiebre.
- Alveolitis seca.
- Alveolitis supurativa.
- Retraso en la cicatrización.
- Necesidad de procedimientos complementarios.

TERCEROS MOLARES SUPERIORES (18 y 28)

- Comunicación bucosinusal.
- Desplazamiento de fragmentos dentarios al seno maxilar.
- Sinusitis odontógena.
- Necesidad de procedimientos adicionales para cierre de comunicación bucosinusal.
- Sangrado asociado a estructuras vecinas.

TERCEROS MOLARES INFERIORES (38 y 48)

- Lesión temporal o permanente del nervio alveolar inferior.
- Alteración temporal o permanente de la sensibilidad del labio inferior.
- Alteración temporal o permanente de la sensibilidad del mentón.
- Lesión temporal o permanente del nervio lingual.
- Alteración temporal o permanente de la sensibilidad de la lengua.
- Sensación de hormigueo, adormecimiento o pérdida de sensibilidad.
- Fractura radicular.
- Fractura ósea mandibular en casos excepcionales.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA ANESTESIA LOCAL

- Dolor en el sitio de punción.
- Hematoma.
- Inflamación.
- Trismus.
- Mordeduras accidentales.
- Parestesia temporal.
- Reacciones alérgicas.
- Síncope vasovagal.
- Palpitaciones transitorias.
- Complicaciones médicas imprevisibles poco frecuentes.

SITUACIONES CLÍNICAS IMPREVISIBLES Y ALTERNATIVAS**Situaciones no visibles previamente:**

- Dilaceraciones radiculares.
- Hipercementosis.
- Anquilosis.
- Fracturas dentales.
- Alteraciones anatómicas.
- Inclusiones más profundas de lo diagnosticado.
- Mayor proximidad a estructuras nerviosas o sinusales.
- Necesidad de ampliar el procedimiento quirúrgico inicialmente planificado.

Autorizo al profesional para realizar las modificaciones necesarias orientadas a **preservar mi salud y seguridad**.

Alternativas de tratamiento:

- Observación clínica periódica.
- Manejo farmacológico temporal.
- Tratamiento de infecciones agudas.
- No realizar la extracción, comprendiendo los riesgos de dicha decisión.

INDICACIONES POSTOPERATORIAS

Comprendo que debo cumplir las siguientes indicaciones:

- Mantener la gasa según indicación profesional.
 - Aplicar frío local durante las primeras horas.
 - No fumar.
 - No consumir bebidas alcohólicas.
 - No escupir durante las primeras horas.
- Seguir estrictamente la medicación prescrita.
 - Mantener adecuada higiene oral.
 - Asistir a controles postoperatorios.
 - Informar inmediatamente cualquier sangrado abundante, fiebre, dolor intenso, dificultad respiratoria o alteración sensitiva persistente.

DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que he recibido explicación suficiente sobre el diagnóstico, hallazgos radiográficos, procedimiento propuesto, beneficios, riesgos generales y específicos, posibles complicaciones, limitaciones y alternativas terapéuticas.

He tenido la oportunidad de realizar preguntas y todas han sido respondidas satisfactoriamente.

Comprendo que toda cirugía oral implica riesgos inherentes y que no existen garantías absolutas respecto a los resultados.

Por lo anterior, autorizo libre y voluntariamente la realización de la exodoncia del(los) tercer(os) molar(es) descrito(s) en este documento.

FIRMAS Y AUTORIZACIÓN

PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL	ODONTÓLOGO TRATANTE	TESTIGO (Opcional)
Nombre completo:	Nombre:	Nombre:
Documento de identidad:	Registro profesional:	Documento:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma	Firma	Firma

OBSERVACIONES